

Dalla fragilità ai bisogni

Una persona può essere fragile. E poi?

Come comprendiamo i suoi bisogni e decidiamo che cosa fare?

Oggi: cosa dovrete sapere?

1. VMD = processo

Valutare → condividere → progettare → rivalutare

2. Modelli e scale = strumenti

Le **5M** orientano; le **scale** si scelgono e si imparano a usare.

3. La persona orienta il progetto

Bisogni, risorse e preferenze guidano obiettivi e interventi.

VMD: una definizione

La **Valutazione Multidimensionale geriatrica** è un

processo multidimensionale e multiprofessionale

che identifica e integra i bisogni della persona, per costruire un **progetto personalizzato e coordinato**, da **rivalutare** nel tempo.

La VMD non è...

Non solo

- Un elenco di problemi
- Una batteria di scale
- Un punteggio finale

È anche

- Bisogni **e risorse**
- Decisioni **condivise**
- Un progetto **da verificare**

La VMD è un percorso

Valutare la persona e il contesto



Identificare e condividere bisogni e risorse



Concordare priorità e obiettivi



Attuare interventi coordinati



Rivalutare e adeguare il progetto ■

Perché lavorare insieme?

Informazioni diverse → comprensione condivisa → interventi coordinati

Un bisogno riconosciuto ma **non comunicato** può non trovare risposta.

Multidimensionale $\neq$ identica per tutti

Quali dimensioni approfondire?

Dipende dalla **persona**, dal **quesito** e dal **contesto**.

Le 5M: una guida, non «IL modello»

- **Mind** · cognizione e umore
- **Mobility** · mobilità e autonomia
- **Medications** · terapia e rischi
- **Multicomplexity** · complessità clinica e sociale
- **What Matters Most** · preferenze e obiettivi

Una mappa utile. Non un protocollo obbligatorio.

Attività 1 · La sig.ra M

Leggete il caso.

1. Quali **bisogni e risorse** emergono?
2. Usate le **5M** come guida, non come obbligo.
3. Quali **2 informazioni** mancano?
4. Che cosa approfondireste **per primo**?
Perché?

[Apri il caso](files/sigraM_casoclinico.pdf)



Discussione · Una sola «M» corretta?

Gruppi diversi, priorità diverse.

Chi ha ragione?

Conta la **motivazione**, non riempire tutte le caselle.

Le scale: quale domanda devo affrontare?

Prima il bisogno. Poi lo strumento.

Cosa devo sapere? Perché? Per chi? Dove?

Le scale: un metodo in 5 domande

1. **Scopo** · Che cosa misura?
2. **Applicabilità** · Per chi e in quale setting?
3. **Somministrazione** · Chi, come, con quali fonti?
4. **Interpretazione** · Che cosa significa il risultato?
5. **Utilizzo** · Come informa il progetto o il monitoraggio?

Che cosa devo ricordare?

Divento pratico nelle scale del mio lavoro.

Quando una scala è nuova:

consulto le istruzioni, verifico se è adatta, imparo ad applicarla.

Attività 2 · Una scala sconosciuta

Aprirete il manuale e scegliete una scala.

Cercate:

- scopo e destinatari;
- come si somministra e si interpreta;
- un **errore da evitare**.

Restituzione: 1 scoperta utile / gruppo.

[<u>QR per il manuale delle scale</u>](https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=260x260&margin=12&data=https%3A%2F%2Fassr.regione.emilia-romagna.it%2Fpubblicazioni%2Frapporti-documenti%2Fmanuale-di-istruzioni-per-il-set-minimo-di-scale%2F%40%40download%2FpublicationFile%2Fmanuale_istruzioni_set.pdf)

****Apri il manuale (PDF) ■****{target="_blank"}

PAUSA

10 minuti

Debriefing · La scala non è la VMD

Raccolta standardizzata



Interpretazione integrata



Decisione personalizzata

Leggere i risultati: con prudenza

Un punteggio aiuta a descrivere una dimensione.

Non racconta, da solo, **tutta la persona.**

Che cosa manca? Con chi dobbiamo condividere il risultato?

Tre persone, stessa età

Dimensione (strumento)	A · 86 anni	F · 86 anni	C · 86 anni
---	--:	--:	--:
Cognizione · MMSE	16	4	28
Autonomia · Barthel	75	0	85
IADL perse (su 8)	6	8	2
Nutrizione · MNA-SF	3	NV	14
Mobilità · Tinetti	21	0	17
Comorbilità · CIRS	3	7	9

Attività 3 · Che cosa sappiamo?

Confrontate i tre profili.

1. Quali differenze emergono?
2. Quale informazione manca **per ciascuna** persona?
3. Che cosa riferireste a un **altro professionista**?

Debriefing · Oltre i punteggi

Risultati + contesto + preferenze + osservazioni dell'équipe

→ comprensione condivisa dei bisogni

Non tutti i problemi diventano obiettivi

- Non tutto è **modificabile**.
- Non tutto è **prioritario**.
- Non tutto conta allo stesso modo **per la persona**.

Bisogno → obiettivo → intervento

Bisogno · Non riesce più a uscire di casa.

Obiettivo · Uscire almeno una volta a settimana, se è ciò che desidera.

Interventi · Accompagnamento, adattamento dell'ambiente, rete sociale.

Cosa conta per la sig.ra M?

«Vorrei riuscire almeno a tornare a cucire.»

Un obiettivo significativo può orientare più interventi.

Attività 4 · Dalla VMD al progetto

Riprendete la sig.ra M.

- **1 bisogno** prioritario e perché;
- **1 obiettivo** significativo e verificabile;
- **2 interventi** e chi coinvolgere;
- **come e quando** rivalutare.

[Apri il caso](files/sigraM_casoclinico.pdf)



Nuove informazioni: il progetto cambia?

Dopo alcune settimane, l'obiettivo non è raggiunto.

La sig.ra M riferisce **paura di lasciare la casa incustodita.**

La nipote **non può accompagnarla** nei giorni concordati.

Che cosa modificate? Che cosa verificate?

Debriefing · Rivalutare $\neq$ ripetere un test

Verificare i risultati



Comprendere che cosa è cambiato



Concordare gli adeguamenti

Verifica finale · 3 domande

1. La VMD è una **batteria di scale** o un **processo**?
2. Le **5M** sono un modello possibile o l'unico modello?
3. Che cosa fare **quando cambia la situazione** della persona?

Tre idee da portare all'esame

La VMD è un PROCESSO.

Le 5M e le scale sono STRUMENTI.

Il progetto è PERSONALIZZATO e RIVALUTABILE.

Materiali e fonti

- [British Geriatrics Society · CGA](#)
- [Geriatrics 5Ms · articolo di riferimento](#)
- [Caso della sig.ra M](files/sigraM_casoclinico.pdf)